

消炎痛的药物相互作用

江西高安县药品检验所 邹敏华

消炎痛为非甾体抗炎药,具有解热、镇痛及消炎作用。目前认为,其作用均可能与抑制前列腺素合成有关。临床上已用于风湿性关节炎、强直性脊椎炎、骨关节炎、急性痛风、体位性低血压、眼科疾患、痛经、胆绞痛等。由于其作用显著、疗效确切,已为临床医生所习用。但随着本品使用的日趋广泛,与其它药物配合使用的情况逐渐增多,而发生药物间相互作用的现象亦同时增多。本文就消炎痛与其它药物间发生的药物相互作用作一简述,以供临床参考。

一、阿司匹林^[1,2]

与消炎痛同服,可使消炎痛的血浆浓度降低,从而降低消炎痛的疗效。其机理可能是阿司匹林在肠内抑制了消炎痛的吸收,改变了其吸收速率,也可能与改变其肾清除率有关。目前认为,合用效果不如单独用消炎痛效果为好。

二、保泰松^[2]

一患者由于服用保泰松导致肾功能衰竭,恢复期间服用消炎痛,结果引起肾功能暂时性恶化。这是由于消炎痛竞争性地抑制了保泰松对血浆蛋白的结合,残留的保泰松被消炎痛从其结合部位所取代。

三、丙磺舒^[2-4]

消炎痛为有机酸,丙磺舒可竞争性地抑制消炎痛在肾小管的分泌,导致排泄减少,血浆浓度升高,从而增加消炎痛的不良反应。为了避免消炎痛不良反应的增加,两药合用时应当减少消炎痛的剂量。

四、呋苯胺酸^[5,6]

同服呋苯胺酸可降低消炎痛的血清浓度,而消炎痛又能降低呋苯胺酸的促钠排池作用,

导致水钠潴留,对心脏病患者可加重心衰,故两药不宜合用。

五、氨苯蝶啶^[7]

合用氨苯蝶啶可引起肾衰。其机理可能是消炎痛抑制了前列腺素的活性,而后者可保护肾脏免受氨苯蝶啶可能引起的肾中毒。

六、苯丙醇胺^[2]

一例服苯丙醇胺的患者,在服用单剂量的消炎痛后,发生严重的高血压症,并导致心动过缓。苯丙醇胺是一种间接作用的拟交感胺,具有收缩血管的作用,可能引起高血压,而消炎痛也能升高血压,故合用能产生严重的高血压症。其机理认为是:消炎痛抑制了血管内壁的前列环素(prostacyclin)和肾髓质PGA、PGE的合成,结果导致不能与苯丙醇胺的血管收缩作用发生对抗,使血压急剧升高,继而反射性地兴奋动脉压力感受器,引起心动过缓。故两药不宜合用,尤其是高血压患者。

七、碳酸锂^[6,8]

锂盐的肾清除率与肾前列腺素的合成有关,消炎痛为前列腺素合成酶抑制剂,故能降低锂盐的肾清除率,使锂盐的血浆浓度升高,从而诱发锂中毒。

八、抗酸药^[2]

与三硅酸镁、氧化镁、碳酸钙、氢氧化铝、白陶土等抗酸药同服,由于消炎痛被它们所吸附,加之消炎痛在碱性介质中不稳定,故在一定程度上可影响其吸收,使血清浓度降低。必需合用时,至少应隔开两小时。

九、洋地黄甙^[2]

三例早产儿服用消炎痛导致洋地黄中毒。这可能与消炎痛提高洋地黄血清浓度,减少其

分布容积有关。但这种相互作用在成人中尚未发现。

十、抗凝药^[2,6]

同服消炎痛通常不会改变抗凝药（如华法令、新抗凝等）的抗凝作用，对抗凝血药所产生的低凝血酶元血症也无影响，但使用抗凝药的病人在加服消炎痛时，应观察病人凝血酶元时间的改变，溃疡病患者更应谨慎使用。

十一、抗高血压药^[2]

服用消炎痛可使正在服心得安、心得静、丁苯氧酸或噻嗪类利尿剂患者的降压作用受到影响。其原因是消炎痛抑制了肾髓质PGA和PGE的合成和释放，而这两种前列腺素对全身外周动脉具有强大的扩张作用。因此认为，在服用抗高血压药时，不宜服用消炎痛。

十二、皮质激素^[4]

消炎痛与适量的皮质激素合用，可提高对风湿病的疗效；对改善慢性肾炎症状及减轻蛋白尿亦有一定作用。但目前认为消炎痛与皮质

激素合用，可能增加胃肠道溃疡的发生率。关于这一点，尚需进一步确证。

十三、菌苗^[2]

消炎痛的抗炎作用能改变机体对感染的反应，可以引起严重的接种反应。提示消炎痛能掩盖感染的体征和症状，同时用活菌苗免疫应在密切看护下进行。

参 考 文 献

- [1] 杨毓瑛等. 中国医院药学杂志 1984; 4(2):7
- [2] Ivan H. *Drug interactions*. Alden Press, 1981: 42-45; 53; 153; 224; 304; 413
- [3] 上海第一医学院主编. 药理学. 第一版. 四川: 人民卫生出版社, 1981:85
- [4] 唐镜波等. 药物相互作用. 第一版. 安阳: 河南科学技术出版社, 1981; 201
- [5] 苏开仲译. 药学情报通讯 1984; 1:35
- [6] 国家基本药编委会. 国家基本药物. 第一版. 北京: 人民卫生出版社, 1984; 151-152
- [7] 管延臣译. 药学情报通讯 1985; 2:15
- [8] 苏开仲译. 药学情报通讯 1985; 2:18

甲巯丙脯酸临床应用中应注意的问题

河南安阳市灯塔医院内二科 王 跃 钢

甲巯丙脯酸(Captopril, 简称CPT)是一种对血管紧张素转换酶有抑制活性的口服新药, 能降低多种高血压患者的动脉血压, 并已证实它是治疗顽固型充血性心力衰竭的重要药物。该药自1982年经美国FDA批准正式用于临床^[1]以来, 已收到明显效果。但用于临床时间毕竟较短, 应用中不断发现一些值得注意的问题, 本文拟对此做一简述, 以期使该药得到更合理的应用。

一、关于适应症问题

CPT对高血压患者有较好的疗效, 最适用于经应用多种降压药物见效差或出现难以忍受的副作用的Ⅱ、Ⅲ期高血压或肾性高血压患者。在Ⅰ、Ⅱ期高血压应用其它降压药物可将

血压控制在正常或接近正常的, 就不宜选用CPT, 以保留一种对较严重高血压较为有效的药物。

CPT还可用于对常规利尿剂及洋地黄治疗见效不大或难以控制的心衰病人, 并可与利尿剂、洋地黄合用。而对于应用其它药物能将心衰控制的患者, 最好不作为首选。

二、关于首次应用剂量问题

CPT经过几年来的应用, 临床上遇到了不少易感性患者, 因此在应用时, 首剂应从小剂量开始。据国外报告1例严重心衰伴有血浆肾素活性大于58.6ng/ml·h(注: 正常值为1.5~4ng/ml·h)的患者, 服用本品6.25mg后即发生明显低血压, 需用多巴酚丁胺治疗。